

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Alcohol (AUDIT)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Alcohol
Sigla	AUDIT
Autores	Babor, T. F., et al. (OMS)
Año	2001
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Uso problemático de sustancias
Población	Adolescentes y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí
Acceso/licencia	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Nota curatorial de derechos	Mantener texto, scoring, credits y avisos OMS.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Uso problemático de sustancias. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	3 subescalas (Consumo de riesgo, Síntomas de dependencia, Consumo perjudicial).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adolescentes y adultos
Número de ítems	10 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de frecuencia/cantidad (0 a 4 puntos).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 subescalas (Consumo de riesgo, Síntomas de dependencia, Consumo perjudicial).
Ítems	10 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de frecuencia/cantidad (0 a 4 puntos).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria simple (0 a 40 puntos).

Regla de corrección	Sumatoria simple (0 a 40 puntos).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuación ≥ 8 indica consumo de riesgo/perjudicial (en varones; ≥ 6 en mujeres frecuentemente).

Puntuaciones $\geq 13-15$ sugieren dependencia del alcohol.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Específico para alcohol. Altamente sensible.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Específico para alcohol. Altamente sensible.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Uso problemático de sustancias en Adolescentes y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Babor, T. F., et al. (OMS); 2001.
- Disponibilidad española reportada: Sí
- Trazabilidad local: 4 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Uso problemático de sustancias
Población	Adolescentes y adultos
Estructura	Catálogo: 10 ítems.; 3 subescalas (Consumo de riesgo, Síntomas de dependencia, Consumo perjudicial).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria simple (0 a 40 puntos).
Interpretación	Puntuación ≥ 8 indica consumo de riesgo/perjudicial (en varones; ≥ 6 en mujeres frecuentemente). Puntuaciones $\geq 13-15$ sugieren dependencia del alcohol.
Estado de fuentes	Locales válidos: 4; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Babor, T. F., et al. (OMS) (2001). Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Alcohol.

Fuente de referencia del catálogo: [OMS AUDIT](<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MSB-01.6a>)

<https://iris.who.int/handle/10665/331321>

<https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x>

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331321/WHO-MSD-MSB-01.6a-spa.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	AUDIT español, 10 ítems, forma de autoadministración. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 e0a2cd8538694e020da553c0ca9707351b00bc5e6b5fe0fa118bb23a2a1e0ecd.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	AUDIT español, 10 ítems, forma de autoadministración.
6. Periodo temporal	Último año, salvo ítems de historia/consecuencias con anclajes propios.
7. Escala/formato de respuesta	Cinco categorías en la mayoría; puntuación 0–4 por ítem según clave.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar los 10 ítems. P1–P8 puntúan 0–4; P9–P10 puntúan 0, 2 o 4. Rango 0–40. Los umbrales dependen de población/sexo/edad y no sustituyen evaluación clínica.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntuación ≥ 8 indica consumo de riesgo/perjudicial (en varones; ≥ 6 en mujeres frecuentemente). Puntuaciones ≥ 13 –15 sugieren dependencia del alcohol. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Documento OMS accesible; conservar atribución y revisar condiciones OMS para reutilización/adaptación.
13. Referencias y fuentes verificadas	OMS. AUDIT: Guidelines for Use in Primary Care, 2.ª ed., https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MSB-01.6a .
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.